## 加護病房床位的每月抉擇

你和另一隊，分別是同一家醫學中心裡內科系與外科系的主管團隊——以下簡稱內科隊與外科隊。兩系共用一批數量有限的加護病房床位，急診、病房與術後病人的轉入、轉出，都得在這批床位裡調度。接下來的八個月，每個月月初，兩隊要各自、同時決定本系這個月的「協作投入等級」。你的目標很單純：讓你自己這一系八個月累計的「重症收治量能點數」愈高愈好。你不需要為對方的收治量能負責。

為了避免臨時喬床、影響公平，醫療部規定兩隊必須在每月月初同時決定、同時亮牌。你可以選擇的投入等級有三種：

- **全力共援**：依病情嚴重度共同調度床位，主動讓出可轉出的床位，也接受對方的病人轉入。
- **保留一手**：表面配合共同調度，私下替自家病人預留床位。若對方全力共援、你卻保留一手，你等於用到對方讓出的床位、又守住自己的，短期你的收治量能會衝很高——但對方會被擠到無床可用。
- **優先自保**：床位只給自家病人，不參與共同調度。當雙方都自保，轉床卡關、急診滯留、手術排程延宕，兩隊收治量能都低。

關鍵在於：你這個月的收治量能，不是只由你決定，而是同時取決於你和對方這個月各自的選擇。下面這張表，就是各種組合下、雙方各自會拿到的量能點數。每一格的右上角、以「外」開頭的，是外科隊的量能；左下角、以「內」開頭的，是內科隊的量能。單位都是「重症收治量能點數」。

| 內科隊↓ ／ 外科隊→ | 外：全力共援 | 外：保留一手 | 外：優先自保 |
|---|---|---|---|
| 內：全力共援 | 外：11<br>內：11 | 外：18<br>內：2 | 外：15<br>內：2 |
| 內：保留一手 | 外：2<br>內：18 | 外：8<br>內：8 | 外：15<br>內：3 |
| 內：優先自保 | 外：2<br>內：15 | 外：3<br>內：15 | 外：5<br>內：5 |

## 重症收治量能記錄表｜逐月填寫

**本隊：**☐ 內科隊　☐ 外科隊

| 回合 | 我方投入等級 | 對方投入等級 | 我方本回合量能（點） | 加權係數 | 我方累計量能（點） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | × 1 | |
| 2 | | | | × 1 | |
| 3 | | | | × 1 | |
| 4 | | | | **× 2** | |
| 5 | | | | × 1 | |
| 6 | | | | × 1 | |
| 7 | | | | × 1 | |
| 8 | | | | **× 3** | |

**八個月累計量能總分：**_____點